

Série : diarrhée chronique

1. Une diarrhée postprandiale précoce chez un enfant de 8 ans, évoque en premier lieu :

- a- Une diarrhée inflammatoire
- b- Une diarrhée motrice
- c- Une diarrhée par mal digestion
- d- Une diarrhée par malabsorption
- e- Une diarrhée sécrétoire.

Réponses : b

2. Une diarrhée chronique par mal digestion est évoquée devant des selles :

- a- Anormalement malodorantes
- b- Aqueuses
- c- Graisseuses
- d- Hémorragiques
- e- Volumineuses

Réponses : a, c, e

3. La diarrhée chronique peut être induite par l'usage au long cours de :

- a- La colchine (anti-inflammatoire)
- b- La metformine (biguanide)
- c- La morphine (antalgique pallier 3)
- d- La sertraline (inhibiteur de la recapture de la sérotonine)
- e- La ticlopidine (antiagrégant plaquettaire)

Réponses : a, b, d, e

4. Parmi les hormones suivantes, laquelle est impliquée dans l'absorption intestinale du fer ?

- a- La prolactine
- b- La sandostatine
- c- La somatomédine
- d- La thyroglobuline
- e- L'hepcidine

Réponse : e

5. L'absorption du fer est favorisée par :

- a- L'acidité gastrique
- b- L'acide ascorbique (vitamine C)
- c- Le thé
- d- Les polyphénols
- e- Les phytates

Réponses : a, b

6. Concernant le calcium ingéré:

- a- Il est absorbé par voie paracellulaire exclusive
- b- L'absorption est inhibée par le magnésium
- c- La 1,25 dihydroxy-vitamine D3 est la principale hormone de régulation de l'absorption
- d- Son absorption active a lieu surtout au niveau iléal
- e- Il est principalement stocké au niveau des os.

Réponses : c, e

7. L'absorption intestinale du potassium ingéré :

- a- est active dans l'intestin grêle
- b- est essentiellement duodénale
- c- est efficace à 90%.
- d- est passive dans le colon
- e- est complète

Réponses : c, e

8. Le vibron cholérique secrète une toxine qui induit, au niveau de l'entérocyte, une dysfonction des :

- a- Canaux calciques
- b- Canaux chlorés
- c- Canaux potassiques
- d- Canaux sodiques
- e- Protéines SGLT1.

Réponses : b

9. L'absorption entérocytaire du sodium se fait par :

- a- Un co-transport sodium/glucose
- b- Un co-transport sodium/chlore
- c- Un co-transport sodium/hydrogène (H⁺)
- d- Un canal sodique stimulé par l'aldostérone au niveau iléo-colique
- e- Une diffusion active para cellulaire

Réponses : a, b, d

10. Concernant l'absorption de l'eau :

- a- Elle est maximale au niveau jéjunale et iléale
- b- Elle est favorisée par l'absorption active de potassium
- c- Elle est de l'ordre de 0.9l/24h, au niveau colique
- d- Elle est plus importante au niveau rectal qu'au niveau colique.
- e- Elle se fait uniquement par voie para cellulaire.

Réponses : a, c

11. L'absorption des glucides est essentiellement :

- a- Caecale
- b- Colique
- c - Duodénale
- d- Iléale
- e- Jéjunale distale

Réponse : c

12. Les vitamines hydrosolubles sont :

- a- Vitamine A
- b- Vitamine B12 (Cobalamine)
- c- Vitamine B1 (Thiamine)
- d- Vitamine D
- e- Vitamine K

Réponses : b, c

13. La triade caractéristique de la mucoviscidose chez le nourrisson inclut :

- a. Anémie
- b. Diarrhée chronique
- c. Hypoprotidémie
- d. Iléus méconial
- e. Œdème

Réponse : a, c, e

14. La maladie cœliaque :

- a. est une entéropathie auto-immune
- b. a des manifestations purement digestives
- c. est la conséquence d'une intolérance au saccharose
- d. atteint des sujets génétiquement prédisposés.
- e. requiert une diète alimentaire spéciale jusqu'à l'adolescence.

Réponses : a, d

15. La maladie cœliaque peut s'associer à :

- a. Un diabète de type 1
- b. Un déficit en IgA
- c. Une Trisomie 21
- d. Un Syndrome de Turner
- e. Un Syndrome de Klinefelter.

Réponses : a, b, c, d

16. Les manifestations cliniques typiques de la maladie coelique chez le nourrisson incluent :

- a. anorexie
- b. ballonnement abdominal
- c. cassure staturale puis pondérale
- d. diarrhée chronique,
- e. rectorragie

Réponses : a, b, d

17. Le diagnostic positif de la maladie cœliaque inclut :

- a. la biopsie colique.
- b. l'échographie abdominale
- c. le dosage pondéral des IgG
- d. le dosage des IgA anti-transglutaminases tissulaires.
- e. la scintigraphie digestive à l'albumine marquée.

Réponse : d

18. La maladie cœliaque peut se traduire par les signes extra-digestifs suivants :

- a. aménorrhée
- b. ictère cholestatique
- c. puberté précoce
- d. retard de croissance
- e. retard pubertaire

Réponse : a, d, e

19. Les perturbations biologiques pouvant être observés au cours de la maladie cœliaque, sont :

- a. anémie ferriprive réfractaire
- b. anticorps anti nucléaires positifs à 1/1280.
- c. augmentation des transaminases
- d. hypo protidémie
- e. hyper alapha-2-globulinémie

Réponse : a, c, d

20. La lésion cutanée caractéristique de la maladie cœliaque est :

- a. l'érythème noueux
- b. l'érythème polymorphe
- c. l'eczéma
- d. le purpura infiltré déclive
- e. la dermatite herpétiforme

Réponse : e

21. Les manifestations ostéo-articulaires de la maladie cœliaque incluent :

- a. l'ostéomalacie
- b. l'ostéopénie
- c. les douleurs osseuses à prédominance nocturne
- d. les fractures
- e. la tumeur brune de l'os

Réponses : a, b, d

22. La maladie cœliaque peut entraîner

- a. fatigue chronique
- b. hémorroïdes
- c. hypertrophie gingivale
- d. hypoplasie de l'émail dentaire
- e. syndrome hémorragique

Réponses : a, d, e

23. Les complications de la maladie cœliaque non traitée, comportent :

- a. l'appendicite
- b. le cancer du côlon uniquement
- c. le lymphome intestinal
- d. l'invagination intestinale récidivante.
- e. l'ulcère gastrique

Réponses : c, d

24. Les aliments qui doivent être exclus du régime sans gluten sont :

- a. blé, orge, seigle
- b. légumineuses
- c. riz, maïs, quinoa
- d. oléagineux
- e. pomme de terre, soja

Réponse : a.